Клинические рекомендации

Дифференцированный рак щитовидной железы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы **D44.0** — Щитовидной железы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 07.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов; Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Ассоциации эндокринных хирургов; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/329_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Физикальное обследование 4

3.4 Лабораторные исследования 5

3.5 УЗИ щитовидной железы и шеи 5

3.6 Оценка гортани 5

3.7 Тонкоигольная аспирационная биопсия 5

4. Лечение 6

4.1 Показания к операции по цитологии 6

4.2 Объём операции 6

4.3 Стратификация риска и радиойодтерапия 6

4.4 Терапия левотироксином натрия 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Диспансерное наблюдение 7
5.2 Показания к госпитализации 7
6. Источник и актуальность 7
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Дифференцированный рак щитовидной железы — злокачественная опухоль из фолликулярных клеток, сохраняющих признаки дифференцировки. Специфической клиники не имеет и, как правило, проявляется как узловой зоб.
- **Оториноларингологу**
  1. всем пациентам с раком щитовидной железы или подозрением на него до операции выполняется видеоларингоскопия для оценки подвижности голосовых складок, независимо от субъективной оценки голоса;
  2. при невозможности — УЗИ голосовых складок;
  3. при подозрительных ультразвуковых признаках узла — УЗИ гортани для исключения инвазии в гортань и пареза голосовой складки из-за вовлечения возвратного гортанного нерва.
- **ТАБ по системе EU-TIRADS**
  1. EU-TIRADS 3: узлы **2,0 см и более**;
  2. EU-TIRADS 4: **1,5 см и более**;
  3. EU-TIRADS 5: **1,0 см и более**;
  4. узлы **менее 1 см**: только при факторах риска — повышенный кальцитонин, увеличенные узлы, облучение головы и шеи, паралич голосовой складки, возраст до 18 лет.
- При IV, V и VI категории цитологического заключения по Bethesda показано хирургическое лечение; объём — от гемитиреоидэктомии при опухоли до 4 см без инвазии и метастазов до тиреоидэктомии при опухоли более 4 см, экстратиреоидной инвазии или метастазах.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Дифференцированный рак щитовидной железы — злокачественная опухоль из фолликулярных клеток щитовидной железы, сохраняющих присущие им признаки дифференцировки.

2.2 Этиология и эпидемиология

Основными факторами развития являются мутации генов (BRAF, PTEN, RAS, TERT и др.), воздействие ионизирующего излучения, наследственные синдромы (Гарднера, Каудена, множественной эндокринной неоплазии 2А и 2В типа).

В 2021 г. рак щитовидной железы составил 2,16% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями; средний возраст пациентов — 54 года. Стандартизированная заболеваемость — 6,14 на 100 тыс. населения, смертность — 0,32 на 100 тыс.

2.3 Классификация

Первичная опухоль (T), AJCC 8-е изд.

1. **T1a** — опухоль **менее 1 см**, ограниченная тканью железы
2. **T1b** — **более 1, но менее 2 см**
3. **T2** — **более 2, но не более 4 см**
4. **T3a** — **более 4 см**, ограниченная тканью железы
5. **T3b** — любого размера с макроскопическим распространением за капсулу с инвазией только в подподъязычные мышцы
6. **T4a** — распространение на подкожные мягкие ткани, гортань, трахею, пищевод, возвратный нерв
7. **T4b** — распространение на предпозвоночную фасцию, сосуды средостения или оболочку сонной артерии

Группировка дифференцированного рака по стадиям

Стадия	До 55 лет	55 лет и старше
I	любое T, любое N, M0	T1–T2 N0/Nx M0
II	любое T, любое N, M1	T1–T2 N1 M0; T3a/b любое N M0
III	—	T4a любое N M0
IVA / IVB	—	T4b любое N M0 / любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Дифференцированный рак не имеет специфической клинической картины и, как правило, проявляет себя как узловой зоб. Анапластический рак проявляется быстро растущим образованием на передней поверхности шеи; позже присоединяются нарушения дыхания и глотания, увеличение регионарных лимфатических узлов.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

До операции диагноз устанавливается по результатам цитологического исследования пунктатов щитовидной железы, изменённых лимфатических узлов шеи и смывов из иглы на тиреоглобулин; после операции — по плановому патолого-анатомическому исследованию.

3.2 Жалобы и анамнез

Факторы высокого риска при узловом зобе

1. семейный анамнез рака щитовидной железы;
2. облучение головы и шеи в анамнезе;
3. дисфагия, дисфония;
4. узлы, случайно выявленные при ПЭТ с флудезоксиглюкозой;
5. операции по поводу рака щитовидной железы в анамнезе.

3.3 Физикальное обследование

Обращают внимание на изменение контуров шеи, узловое образование в щитовидной железе, увеличение регионарных лимфатических узлов, изменение голоса.

3.4 Лабораторные исследования

При узловом образовании исследуют кальцитонин крови — для исключения медуллярного рака, и тиреотропный гормон. Повышение базального кальцитонина **более 100 пг/мл** крайне подозрительно в отношении медуллярного рака.

Дооперационное исследование тиреоглобулина у первичных пациентов с узлами не рекомендовано: на этом этапе он не является маркером рака.

3.5 УЗИ щитовидной железы и шеи

Подозрительные ультразвуковые признаки узла

1. гипоэхогенная солидная структура;
2. неровный, нечёткий или полициклический контур;
3. точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты);
4. преобладание переднезаднего размера над шириной («выше, чем шире»).

3.6 Оценка гортани

Всем пациентам с раком щитовидной железы или подозрением на него на дооперационном этапе, независимо от субъективной оценки голосовой функции, выполняется видеоларингоскопия для объективной оценки подвижности голосовых складок; при невозможности — УЗИ голосовых складок.

При подозрительных ультразвуковых признаках узла выполняется УЗИ гортани — для исключения инвазии опухоли в гортань и/или пареза голосовой складки вследствие вовлечения возвратного гортанного нерва.

3.7 Тонкоигольная аспирационная биопсия

ТАБ под ультразвуковым контролем является основным методом дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных поражений щитовидной железы и лимфатических узлов.

Показания определяются категорией EU-TIRADS и размером узла; при узлах менее 1 см вне группы риска агрессивных форм ТАБ нецелесообразна независимо от ультразвуковых характеристик.

Срочное направление на биопсию в специализированный центр

1. солидный гипоэхогенный узел, быстро увеличивающийся в размерах (**более 1 см в месяц**);
2. без болевого синдрома и кистозной трансформации;
3. особенно при затруднении дыхания, нарушении голоса или глотания.

Наиболее быстро растущими новообразованиями щитовидной железы являются анапластический рак и лимфома.

Цитологическая классификация Bethesda

1. I — неинформативная пункция;
2. II — доброкачественное образование;
3. III — атипия неопределённого значения;
4. IV — фолликулярная неоплазия или подозрение на неё;
5. V — подозрение на злокачественную опухоль;
6. VI — злокачественная опухоль.

КТ шеи и органов грудной полости с контрастированием выполняется при опухоли Т3–4, подозрении на экстратиреоидное распространение, изменённых регионарных лимфатических узлах по данным УЗИ.

4. Лечение

4.1 Показания к операции по цитологии

1. **Bethesda IV, V, VI** — хирургическое лечение
2. **Bethesda III** — повторная пункция для уточнения риска злокачественности

4.2 Объём операции

Объём операции по размеру и распространённости опухоли

Ситуация	Объём операции
интратиреоидная опухоль менее 1,0 см (IV–VI)	гемитиреоидэктомия; альтернатива по выбору пациента — активное наблюдение с экспертным УЗИ 1 раз в полгода
V–VI, 1–4 см, без экстратиреоидной инвазии и метастазов (cN0)	гемитиреоидэктомия или тиреоидэктомия
V–VI, более 4 см, выраженная экстратиреоидная инвазия (cT3), cN1 или M1	тиреоидэктомия с максимальной хирургической абляцией опухолевой ткани

1. **центральная зона (VI уровень)** — удаление — при подозрении на метастазы до или во время операции
2. **профилактическая центральная лимфаденэктомия** — при T3–4 или верифицированных метастазах в боковой клетчатке шеи
3. **II–V уровни** — только при доказанном по ТАБ метастатическом поражении; селективное удаление узлов вне футлярно-фасциального блока неадекватно

4.3 Стратификация риска и радиойодтерапия

Низкий риск — радиойодтерапия обычно не показана

1. нет локорегионарных и отдалённых метастазов;
2. удалена вся опухолевая ткань;
3. нет экстратиреоидной и сосудистой инвазии, неагрессивный гистологический вариант;
4. нестимулированный тиреоглобулин **1 нг/мл и менее** **через 6–12 недель** после тиреоидэктомии.

Промежуточный риск — радиойодтерапия индивидуально

1. агрессивный гистологический вариант;
2. поражение более 5 лимфатических узлов, сосудистая инвазия, положительный край резекции;
3. нестимулированный тиреоглобулин **до 10 нг/мл** **через 6–12 недель**.

Высокий риск — абсолютные показания к радиойодтерапии

1. резидуальная опухоль;
2. метастатический узел **более 3 см**;
3. макроскопическая экстратиреоидная инвазия;
4. широко инвазивный фолликулярный рак, подозрение на отдалённые метастазы;
5. нестимулированный тиреоглобулин **более 10 нг/мл**.

Для подготовки к радиойодтерапии без тиротропина альфа левотироксин натрия отменяют **за 3–4 недели**; проводится 2-недельная диета с низким содержанием йода, после рентгеноконтрастных исследований натрия йодид [^{131}I] не назначают **в течение 2 месяцев**.

4.4 Терапия левотироксином натрия

Целевые уровни ТТГ

1. супрессивная терапия: ТТГ **менее 0,1 мЕд/л**;
2. мягкая супрессия: **0,1–0,5 мЕд/л**;
3. заместительная терапия: **0,4–4,0 мЕд/л**.

В группе низкого риска и при биохимической ремиссии супрессивная терапия не рекомендуется — проводится заместительная.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Динамическая стратификация риска

1. **биохимическая ремиссия** — УЗИ без изменений, нестимулированный тиреоглобулин **менее 0,2 нг/мл**; вероятность рецидива 1–4%
2. **биохимический рецидив** — нестимулированный тиреоглобулин **более 1 нг/мл**, стимулированный **более 10 нг/мл**, вираж антител к тиреоглобулину
3. **структурный рецидив** — структурные или функциональные признаки опухоли при любой концентрации тиреоглобулина

После операции УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желёз и лимфатических узлов шеи выполняется **через 6–12 месяцев** в зависимости от группы риска и динамики тиреоглобулина. При подозрительных узлах **более 0,8–1,0 см** — прицельная ТАБ с определением тиреоглобулина в смыве из иглы.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Дифференцированный рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	329_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Российская ассоциация эндокринологов и др.
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.